

TEMA 4.24 • DERMATOLOGÍA

Melanoma Maligno

PERFIL EUNACOM 1.09.1.006
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Melanoma Maligno** es una neoplasia derivada de los melanocitos. Es el cáncer de piel más agresivo debido a su alta capacidad de generar metástasis. Su comportamiento clínico está dictado por una combinación de factores ambientales y predisposición genética.

Epidemiología y Etiología

El principal factor de riesgo ambiental es el **fotodaño** (exposición a radiación UV). Sin embargo, posee un componente genético significativo, lo que explica la aparición de melanomas en zonas no expuestas al sol.

Ubicación más frecuente según sexo: Hombres: Espalda. **Mujeres:** Piernas. **Zonas no fotoexpuestas:** Planta de los pies, mucosas (boca, genitales).

NOTA CLÍNICA

Aunque el sol es el gatillante principal, el componente genético permite que el melanoma aparezca en sitios protegidos (melanoma acral o mucoso), por lo que un examen físico completo debe incluirlos.

Clínica y Signos de Alarma

La lesión puede presentarse como una mácula (plana) o una placa (elevada), generalmente hiperpigmentada.

Para identificar lesiones sospechosas, se utiliza la regla mnemotécnica **ABCDE**:

TABLA 4.24.1: LETRA VS CRITERIO		
LETRA	CRITERIO	DESCRIPCIÓN
A	Asimetría	La mitad de la lesión no es igual a la otra.
B	Bordes	Irregulares, difusos o en "mapa".
C	Color	Heterogéneo (varios tonos de café, negro, azul o rojo).
D	Diámetro	Mayor a 6 milímetros .
E	Evolución	Cambios recientes en tamaño, forma o color (o Exposición solar).
F	Familia	Antecedentes familiares de melanoma.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Existen los **melanomas amelanóticos** (sin pigmento). Al no ser oscuros, suelen confundirse con lesiones benignas, lo que retrasa el diagnóstico y empeora el pronóstico.

Clasificación Clínica del Melanoma

Existen cuatro variantes principales que deben reconocerse:

- **Extensión Superficial:** Es el más frecuente. Crece radialmente antes de profundizar.
- **Melanoma Nodular:** Se presenta como un nódulo. Es de **peor pronóstico** porque tiene un crecimiento vertical (invasivo) rápido desde el inicio.
- **Léntigo Maligno:** Típico en rostros de adultos mayores con mucho daño solar. Es de crecimiento muy lento y suele ser una mácula in situ por mucho tiempo.
- **Melanoma Acral Lentiginoso:** Aparece en palmas, plantas y uñas. Es el tipo más común en personas de fototipos oscuros y no está tan relacionado con el sol.

Pronóstico: El Índice de Breslow

El factor pronóstico más importante en el melanoma localizado es la profundidad de la invasión, medida en milímetros desde la capa granulosa de la epidermis.

Índice de Breslow: Mide la profundidad vertical en mm. **Punto crítico:** Un Breslow de **1 milímetro** marca un cambio significativo hacia un peor pronóstico y define la agresividad de la cirugía.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, siempre que pregunten por el factor pronóstico más importante de un melanoma cutáneo, la respuesta es el **Índice de Breslow**.

Diagnóstico y Manejo

Ante cualquier lesión sospechosa según el ABCDEF o una lesión pigmentada de reciente aparición en palmas/plantas, se debe proceder al estudio.

- **Biopsia Excisional:** Es el estándar de oro. Se debe extirpar la lesión completa con márgenes pequeños (2-3 mm) para estudio histopatológico. **Nunca realizar biopsia incisional o por punch** si es posible sacar toda la lesión, ya que se puede subestimar el Breslow.
- **Ampliación de Márgenes:** Una vez confirmado el diagnóstico y conocido el Breslow, se realiza una segunda cirugía para asegurar la limpieza del área:
- **Breslow ≤ 1 mm:** Ampliación de margen de **1 cm**.
- **Breslow > 1 mm:** Ampliación de margen de **2 cm**.
- **Manejo Avanzado:** Incluye el estudio de ganglio centinela, quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia según el estadio, manejado por el especialista.

Diagnóstico Diferencial

Es fundamental no confundir el melanoma con la **Queratosis Seborreica**. Esta última es una lesión benigna, de aspecto "untuoso" o verrugoso, con superficie agrietada y que parece "pegada" sobre la piel. A diferencia del melanoma, no tiene potencial maligno.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Toda lesión hiperpigmentada nueva en palmas o plantas en un adulto debe ser derivada a dermatoscopia de forma urgente para descartar melanoma acral.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"¿Qué representa el índice de Breslow en el melanoma maligno?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Melanoma Maligno. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El melanoma maligno es el tumor de piel más mortal aunque no el más frecuente.
- El acrónimo ABCDEF ayuda a identificar lesiones sospechosas de melanoma.
- El melanoma de extensión superficial es el tipo más frecuente.
- El melanoma nodular es el más agresivo por su rápida invasión en profundidad.
- El índice de Breslow mide la profundidad de invasión y es el principal factor pronóstico.
- Con Breslow menor a un milímetro se amplía con margen de un centímetro, y mayor de un milímetro con dos centímetros.
- El melanoma acral afecta palmas, plantas y uñas y es más frecuente en pacientes de piel oscura.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MELANOMA MALIGNO)**PREGUNTA 1**

¿Qué representa el índice de Breslow en el melanoma maligno?

- A)** La velocidad de crecimiento horizontal en milímetros por mes del tumor
- B)** La profundidad de invasión en milímetros desde la epidermis hacia la dermis
- C)** El número de mitosis por milímetro cuadrado en el análisis histológico
- D)** El grado de diferenciación celular del tumor en una escala de uno a cinco
- E)** La distancia en milímetros desde el tumor hasta el ganglio centinela positivo

PREGUNTA 2

¿Cuánto margen quirúrgico se debe ampliar cuando el índice de Breslow es mayor a un milímetro?

- A)** Margen de cero coma cinco centímetros para preservar tejido facial sano
- B)** Margen de un centímetro igual que para los tumores de menor profundidad
- C)** Margen de dos centímetros para reducir el riesgo de recurrencia local
- D)** Margen de tres centímetros para asegurar la eliminación completa del tumor
- E)** Margen de cinco centímetros porque la invasión profunda implica extensión lateral

PREGUNTA 3

¿Cuál es el tipo de melanoma más frecuente?

- A)** El melanoma nodular que crece rápidamente en profundidad
- B)** El léntigo maligno que afecta adultos mayores en zonas fotoexpuestas
- C)** El melanoma de extensión superficial que crece inicialmente en horizontal
- D)** El melanoma acral que afecta palmas, plantas y uñas
- E)** El melanoma amelanótico que carece completamente de pigmento

RESUMEN: MELANOMA MALIGNO

El melanoma maligno es el tumor maligno de piel más mortal aunque no el más frecuente. Tiene un componente de fotodaño importante pero también una carga genética significativa. En hombres se localiza preferentemente en la espalda y en mujeres en las piernas. Para identificar lesiones sospechosas se usa el acrónimo ABCDEF: Asimetría, Bordes irregulares, Color irregular con múltiples tonos, Diámetro mayor a seis milímetros, Evolución rápida o cambio reciente, y antecedente familiar. Los tipos principales son el melanoma de extensión superficial que es el más frecuente, el melanoma nodular que invade rápidamente en profundidad, el léntigo maligno que crece lentamente y alcanza gran tamaño, el melanoma acral en palmas, plantas y uñas que afecta principalmente piel oscura, y el melanoma amelanótico sin pigmento. El índice de Breslow mide la profundidad de invasión en milímetros y es el factor pronóstico más importante. El punto de corte clave es un milímetro. El tratamiento es la biopsia excisional diagnóstica seguida de ampliación de márgenes: un centímetro si la profundidad es menor a un milímetro y dos centímetros si es mayor.